2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

QUANDO A PELE DIZ O QUE O SISTEMA NÃO OUVE: PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA APS

Helena Gonçalves de Souza Santos (SANTOS, H. G. S.)[1] - Doutoranda em Enfermagem (EEAN-UFRJ).
Eduardo de Lima Fonseca (FONSECA, E. L.)[2] - Mestrando em Relações Étnico-Raciais(PPRER-CEFET)
Renata Pedreira da Cruz(CRUZ, R. P.)[3] - Doutora em Saúde Pública (ENSP-FIOCRUZ).
Lucilene Araujo de Freitas(FREITAS, L. A.)[4] - Doutora em Pesquisa Clinica em Doenças Infecciosas (INI-FIOCRUZ)

PRINCIPAIS ACHADOS DO SEU TRABALHO

O racismo institucional manifesta-se na APS por meio de microviolências, estereótipos racializados, subvalorização de queixas clínicas e falhas na comunicação, impactando negativamente o acesso e a qualidade do cuidado ofertado à população negra. Ações educativas e práticas antirracistas no cotidiano dos serviços fortaleceram o acolhimento, qualificaram a escuta clínica e ampliaram a autonomia e a segurança dos usuários no cuidado em saúde.

Introdução
O racismo não é um desvio pontual no funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). É estruturante. Ele atravessa cada escuta clínica, cada exame solicitado, cada encaminhamento, cada silêncio diante de uma queixa de dor. Na Atenção Primária à Saúde (APS), porta de entrada preferencial do sistema, as desigualdades raciais não aparecem como exceção, manifestam-se como regra invisibilizada: a população negra tem menos acesso, menor tempo de consulta, menos exames prescritos, mais sofrimento psíquico negligenciado e menos resolutividade. A enfermagem, por sua posição estratégica no acolhimento, na escuta inicial e na continuidade do cuidado, pode tanto reproduzir essas microviolências, com falas atravessadas por estereótipos, estética corporal julgada, suspeição sobre adesão ao tratamento, quanto romper com elas. Este relato não pretende apenas descrever situações de racismo institucional. O objetivo é mais contundente: analisar, à luz da prática cotidiana em uma clínica da família do Rio de Janeiro, como o racismo se materializa em atos aparentemente banais e, ao mesmo tempo, como práticas deliberadamente antirracistas podem subverter essa lógica, reposicionando o cuidado como ato de justiça racial. A pele diz, e grita, o que o sistema treina seus profissionais a não ouvir. A enfermagem antirracista escolhe ouvir.

Objetivos
Analisar manifestações do racismo institucional na APS e suas implicações para o cuidado à população negra.

Métodos
Relato de experiência em clínica da família do Rio de Janeiro, baseado na observação do processo de trabalho, identificação de barreiras e descrição de ações educativas orientadas pela equidade.

Resultados
Evidenciaram-se microviolências, subdimensionamento de queixas, estereótipos e falhas na comunicação. Intervenções educativas ampliaram acolhimento, qualificação clínica e autonomia dos usuários.

Conclusão/Considerações finais
As microviolências, o subdimensionamento de queixas, os estereótipos sobre comportamento e as falhas na comunicação com a população negra não são falhas individuais de conduta. São expressões de um racismo institucional que se naturalizou dentro das unidades de saúde, disfarçado sob o verniz da técnica e da neutralidade científica. Este relato demonstrou que tais manifestações são enfrentáveis, mas não por meio de boas intenções isoladas. Intervenções educativas permanentes, orientadas pela equidade racial e construídas coletivamente com a equipe de saúde, mostraram-se capazes de ampliar o acolhimento, qualificar a escuta clínica e, sobretudo, devolver aos usuários negros um lugar de protagonismo sobre seu próprio processo saúde-doença-cuidado. Não há APS verdadeiramente universal sem que seja explicitamente antirracista. A enfermagem, se quiser honrar seu compromisso ético com a vida, precisa assumir a educação permanente como ferramenta de descolonização do cuidado. Conclui-se, portanto, que práticas antirracistas não são um capítulo à parte na formação ou na gestão, são o eixo estruturante para que o SUS deixe de reproduzir as injustiças que deveria combater. Quando a pele fala, o sistema não pode mais se dar ao luxo de fingir que não ouve.

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY - UFRJ
HELENA GONÇALVES DE SOUZA SANTOS
DOUTORANDA

E-mail: enfa.helenagss@gmail.com
Contatos: +55 (21)997853101

Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Enfermagem